



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : غاده حسين عيسي عفيفي
المحافظة : القليوبية
الحى / المدينة : شبرا الخيمة
رقم البطاقة : 27308051301567 رقم التليفون : 01018288907
العمر (تاريخ الميلاد) : 05-08-1973 المهنة : حاصل علي بكالوريوس
العنوان : 54 مساكن حجازى
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج :
الأورام [11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: غاده حسين عيسى عفيف National ID: 27308051301567	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٢٥/١٠ ١٧٢.٨.٥١٢.١٥٦٧

حاصلة على معتمد لاجري

متزوجة مسلمة أنثى

صدام محمد محمد إبراهيم

البطاقة مصرية حتى ٢٠٢٢/١٠/٢٥



دولة فلسطين
وزارة الداخلية

شهادة

حاصل على معتمد لاجري

مسافر جازي - مخرج ٥١

شبرا الخيمة أولاد الناصرية



١٧٢.٨.٥١٢.١٥٦٧

LK5974152

١٧٢.٨.٥١٢.١٥٦٧



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

البنية التحتية
للصحة

02/23/2026

MDT FORM

Name:	Gada Huseen Essa Afifi	MRN:	5521
Age:	53 Y	ID:	
Menopausal Sta	PERT MENAPUSAL	Phone:	01018288907
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	
CO Morbidity:	DM, HTN	Reason Of MDT:	post operation

Clinical Data:

BX:	mixed IDC+ ILC G11
ER:	8/8
PR:	8/8
HER2:	0
KI67:	

R

L

Sonomammography:

Mets Workup:

History:

Left breast cancer (Up-front), Left breast wide local excision, Extra-margins & Sentinel lymph nodes biopsy:
 ? Mixed invasive duct & invasive lobular carcinoma, Grade 2 (Predominant ductal component).
 ? Surgical margins: Free (medial, extra-lateral, superior, extra-inferior, skin & extra-deep) surgical margins.
 ? Sentinel lymph nodes: Five free sentinel lymph nodes (0/5) * Stage: pT1c, pN0 (sln).

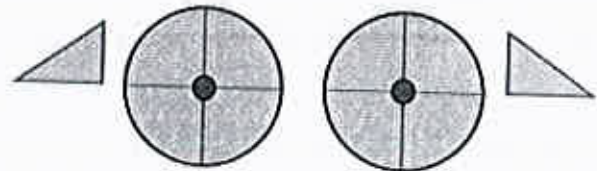
for possibility adj ttt

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

For PORT

adj AI + Zoladex 5y



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ ندى حسين		د/ نرمين رمضان			

Name: <u>غادة حسين عيسى عفيفي</u>			
MR. : <u>5521</u>			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
		بقسم:	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:			
ننشر بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها			
		تاريخ وساعة الدخول :	
		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها			
52 YEARS OLD FEMAE PT WITH LT BREAST CANCER IDC+ILC GII ER 8/8 PR 8/8 HER2-VE Left breast cancer (Up-front), Left breast wide local excision, Extra-margins & Sentinel lymph nodes biopsy: ? Mixed invasive duct & invasive lobular carcinoma, Grade 2 (Predominant ductal component). ? Surgical margins: Free (medial, extra-lateral, superior, extra-inferior, skin & extra-deep) surgical margins. ? Sentinel lymph nodes: Five free sentinel lymph nodes (0/5) * Stage: pT1c, pNO (sln). MDT For PORT adj AI + Zoladex 5y FEMARA CALCIUM 1*1*90 ONE ALPHA PT IS 53 YEARS OLD FOR E2+FSH REPORT FOR PORT DONE Left breast cancer (Up-front), Left breast wide local excision, Extra-margins & Sentinel lymph nodes biopsy: ? Mixed invasive duct & invasive lobular carcinoma, Grade 2 (Predominant ductal component). ? Surgical margins: Free (medial, extra-lateral, superior, extra-inferior, skin & extra-deep) surgical margins. ? Sentinel lymph nodes: Five free sentinel lymph nodes (0/5) * Stage: pT1c, pNO (sln). 2/2026:PORT adj AI + Zoladex 5y TODAY : NO SPCIFIC CAUES FOR VISIT ONLY PSYCHIC SUPPORT !!! FEMARA +SUPPORTIVE*3M (PSYCOLOGICAL PROBLEM). ZOLADEX AT 25/7/2026 NEXT CLINIC VISIT :22/9/2026			
تحريرا في ,			
		التاريخ : 19-09-2026	
		الطبيب المعالج : نهى سعيد علي محمد	
يعتمد ,			

MDT FORM 71 / 1 / 2028 G

Name	فارة حسن	MRN	٣٨٢٣/٢٢٠
Age	52 yr	ID	٢٧٢٠٨٠٥١٢٠١٥٦٧
Menopausal status	Perimenopausal	Phone	٥١٥١٨٢٨٨٩٥٧
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	HCC
CO morbidity	DM, HTN.	REASON OF MDT	

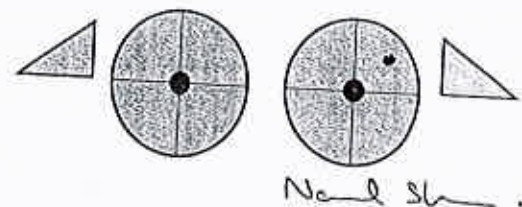
Clinical Data

BX: Mixed IDC & ILC G2

ER: 6/8 PR: 8/8 HER2: neg. Ki67: 15%

Sonomammography:
Left breast 22x14mm.
LDI → neg.

Mets Workup:
CTCAP: - Small multifocal
- Bilateral axillary subcutaneous LN S



Recommendations:
→ radiology series
if free → upfront surgery

MDT OUTCOME & PLAN

CEM was Refused. Pt. is ACR A
For SK in mark
FWLC + SLNB
For CEM (ILC+IDC) + Targeted UIS
then upfront BCS if proved unifocal and
axillary margin according to new UIS assessment

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
M. Kelleh	Amira				

Patient ID: 90055	Patient Name English: Gedeh Hussein Elsa Afify
Age: ٥٢ سنة ٢٣	2025/11/13 01:03:09 PM : Report Date

Women's Health Outreach Program
Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 52 years old, routine screening.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Almost fatty parenchyma, (ACR B₁).
- UOQ anterior third small dense speculated mass
- No suspicious micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated a corresponding hypoechoic non parallel vertically oriented solid mass lesion with marginal echogenic rind and internal vascularity depicted by color Doppler study, it seen at 2:00 para-areolar about 30 mm from the nipple and 8mm from the skin, it measured 22x14mm
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- No pathological axillary LNs.

Right breast

- Almost fatty parenchyma, (ACR B₁).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no suspicious solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Nonspecific axillary LNs.

Impression:

Left breast: (BIRADS 4c): UOQ malignant looking solid mass lesion
 Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Recommendations:

US guided biopsy for histopathological assessment

Best regards,
 Dr. Eman Ali

Patient Name : الأستاذة / غادة حمدان عيسى علقوى
Patient No. : 27308051301567
Path No. : 3693/25
Sex : Female
Age : 52 Y
Referring Doc :
Request No. : 13003669
Request Date : 27/11/2025
Verification Date : 04/12/2025
Financial Category :
Department : Out Patient
Registered by : mervia mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast 2 o'clock mass, BIRADs 4c.
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 27/11/2025, at 04:04 pm, Cold Ischemia
Time: 30 seconds.

Gross Examination:

- Three gray white tissue cores, each measured 1 cm long, totally submitted.

Microscopic Examination:

- Histological type: Mixed Invasive duct & Invasive classic lobular carcinoma.
- Grade 2 (differentiation 3, nuclear pleomorphism 2, mitosis 2).
- Ductal carcinoma in situ: Absent.
- Lobular carcinoma in situ: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Angiolymphatic invasion: Absent.

Diagnosis:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Mixed invasive duct & Invasive classic lobular carcinoma, Grade 2.
- Immunophenotyping for (ER, PR, Her2, Ki67) is in a separate report.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
Dr. Duaa Mohamed.

Verified by :

Printing Date : 16/12/2025 15:05:45

Page 1 of 1

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



عنوان رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Murr El Qadimia - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / غادة محمد عيسى عطوي
Patient No. : 27308051301567
Path No. : 3693/25
Sex : Female
Age : 52 Y
Referring Doc. :

Request No. : 13003669
Request Date : 27/11/2025
Verification Date : 04/12/2025
Financial Category : جويش رومس
Department : Out Patient
IHC No. :
Registered by : marwa mohamed youso

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 27/11/2025.

Technique:

Sections prepared from paraffin block for Immune-staining using Bench Mark ULTRA system for:
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).

PR: Strong nuclear reaction in 98% of tumor cells (score 8/8).

Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).

Ki67%: 15%.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

Fixed Invasive duct & Invasive lobular carcinoma, Grade 2.

ER:

ER: Positive (score 8/8).

PR: Positive (score 8/8).

Her2: Negative (score 0).

Ki67%: 15%.

Scoring system: "ER, PR"

SCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, 1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%; 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, moderate, 3, strong).

Verified by :

Printing Date : 16/12/2025 15:05:46

Page 1 of 2

Printed by : Mrs. Mayada Hegazy

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nisar El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name: الأمشلاه / علاء حسين عيسى عليا
Patient No.: 27308051301567
Path No.: 3693/25
Sex: Female
Age: 52 Y
Referring Doc.:

Request No.: 13003669
Request Date: 27/11/2025
Verification Date: 04/12/2025
Financial Category: جروب روتسي - ميلاده
Department: Out Patient
Registered by: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim.
Dr. Heba El-Shafeey.

Verified by :

Printing Date : 16/12/2025 15:05:46

Page 2 of 2

Printed By : Mrs. Mayada Hegazy

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987 - Nile Corniche - Mit El Qadima - Cairo, Egypt
مركز (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مبنى القديمة - القاهرة - مصر

Patient Name: Ghada Hussein Eisa Afify Zakzok	Date : 18/12/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 3823/2025	Pat. ID: 43933

**MULTISLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS WITH
CONTRAST**

TECHNIQUE: Multi slice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis were obtained followed by multiplanar reconstruction of the source images. I.V contrast administration.

FINDINGS:

CECT CHEST:

****Given history of breast cancer:**

- Bilateral lower lung lobes multifocal pleural thickenings.
- Bilateral axillary enlarged sub centimetric lymph nodes and few right axillary subcutaneous sub centimetric nodules.
- No cavitary lesions or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

CECT ABDOMEN AND PELVIS:

- The liver is average in size showing homogenous CT density with no enhancing focal lesions or biliary radicles dilatation.
- The gall bladder shows average wall thickness. Its cavity shows no dense stones.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas and both kidneys.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- No abdominal or pelvic pathologically enlarged lymph nodes.
- No free collection.

THE SCANNED SKELETON:

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

Opinion:

- Bilateral lower lung lobes multifocal pleural thickenings.
- Bilateral axillary enlarged sub centimetric lymph nodes and few right axillary subcutaneous sub centimetric nodules.
- No hepatic or osseous lesions.

heba elbalsky

Dr. Heba El Balsky, MD
Lecturer and Consultant of Diagnostic and Interventional Radiology,
NLI-Menoufia University

Signature Dr. Mohamed Hassan
22/12/2025 5:00 PM

Name : GHADA HUSSEIN

Branch : Portable

Ref.Physician Prof :

Date : 14-01-2026 03:15

Medical No. : GRI-140126031523PM

Ins.Company :

HIGH RESOLUTION ULTRASOUND OF THE LEFT AXILLA

INDICATION:

- A known case of left breast carcinoma, for preoperative assessment of the axillary nodes

REPORT:

- No pathological axillary node is seen, only few non-specific nodes, with uniform thin cortices.

Best regards,
Dr. Mahi Mokhtar